

Fecha Última Actualización: 17-03-2026 15:30:42

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Vilma Del Carmen Santibáñez Cancino **Rut** : 7.792.846-4 **N° Archivo** : 0609678 **N° Epicrisis**
Edad : 68a 4m 0d **Fecha Nacto**: 17/11/1957 **Sexo** : Femenino **470008**
Dirección : Pje. La Vendimia 2840 V. San Guillermo li **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 928058126-976767283

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 28/12/2025 04:01 **Días Estadía**: 79
Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater) **Fecha Egreso** : 17/03/2026 15:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dificultad Respiratoria

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

- Mórbidos: AR, Fibromialgia, HAI, ICC FEVlr, HTA, LCFA con bronquiolitis asociada a AR, TEP (may/25).
- Qx: colecistectomía, cesárea, fractura diáfisis tibia derecha.
- Fármacos: Abatacept 125mg semanal SC, Sulfazalasina 2g, Azatoprina 100mg, Hidroxicloroquina 200mg, ElcalD, Omeprazol 20mg, AAS 100mg, ATV 20mg, Furosemida 40mg x2, Pregabalina 300mg, Trelegy (fluticasona, vilanterol y umeclidino), Br. ipratropio.
- Alergias: AINES y tramadol (no descrito).
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), Otros (-).
- Hospitalizaciones: mayo-agosto/2025 Fx tibial y TEP.
- Social: Vive con 2 hijos. Desfuncionalizada desde hospitalización previa con dependencia moderada.

HISTORIA INGRESO

Cuadro de 5 días de evolución de compromiso del estado general, aumento de disnea basal y expectoración, además se describen mareos y vómitos. A su ingreso taquicárdica 117 lpm, normotensa 108/85(92)mmHg, afebril, desaturando 86% con 6 L/NRC, descrita desorientada e inatenta, hidratada, bien perfundida, ingurgitación yugular, sin soplos, MP (+) con roncus y sibilancias, abdomen doloroso difuso a la palpación y edema moderado-severo de extremidades inferiores. Laboratorio de ingreso destacó FA 212 GGT 57 GPT 2054 GPT 1155 Crea 3.34 BUN 84 PCR 186 leuco 13670 pH 7.16 CO2 58 HCO2 20.6 INR 1.97. Se conecta a soporte con VMNI con buena respuesta inicial, sin embargo, evoluciona con deterioro hemodinámico y mayor compromiso de conciencia, por lo que se decide IOT el 28/12, sin incidentes. Se traslada a UPC en VMI parámetros protectores, con NAD 0.1.

LABORATORIOS DE INGRESO

28/12: Lac 1.8, Alb 3.4, BT 1.58/BD 1.05, FA 212, GGT 57, GOT 2054, GPT 1155, Ca 8.2, Crea 3.34, TUS 357, BUN 84.3, Gluc 92, Mg 2.3, PCR 186, ELP 130/5.97/95, GSV pH 7.16, PCO2 58.3, HCO3 20.6, Hb 13, GB 13.67, PlaQ 240, INR 1.97
PVR (-) OC levemente inflamatoria.

MICROBIOLOGÍA DE INGRESO

28/12 Panel viral negativo Covid 19 negativo VHB NR VHC NR VIH NR UC polimicrobiano OC no inflamatoria Cultivo aspirado endotraqueal: S. ureus R clindamicina, eritromicina S: cloxacilina, TMS. 28/12 S. aureus aspirado endotraqueal

Fecha Epicrisis : 17/03/2026 15:30

Página 1 de 5

Fecha de Impresión : Miércoles, 25 de Marzo de 2026 23:48

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

IMÁGENES DE INGRESO:

28/12: TAC TAP: No se dispone de protocolo angiográfico pulmonar para descarte de tromboembolismo pulmonar agudo. Se sugiere nuevo control angiográfico pulmonar de persistir sospecha. Moderada a acentuada cardiomegalia con crecimiento de las cavidades derechas. Ateromatosis aórtica. Pequeñas adenopatías mediastínicas de aspecto reactivas. Hernia hiatal con ascenso de unión gastroesofágica y dilatación del esófago. Signos de hepatopatía crónica congestiva. Leve ascitis

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

- 1) Compromiso de conciencia en estudio
- Obs LCFA
- Obs Hepatitis con Insuficiencia Hepática Aguda
- Obs Sepsis de Foco Urinario
- 2) Insuficiencia Respiratoria Aguda.
- 3) Hiperkalemia leve.
- 4) Acidosis Respiratoria.
- Antecedentes.

EVOLUCIÓN POR PLANES

- 1) Hemodinamia: Paciente evoluciona hemodinámicamente inestable, requirió soporte con NAD hasta 0.22 mcg/kg/min a su ingreso, con lenta disminución de soporte hasta lograr suspensión al 10/01. Sin otro conflicto de relevancia durante estadía.
- 2) Cardiovascular: A su ingreso con taquicardia en contexto de Flutter, con signos de injuria cardíaca, sin franca isquemia, dado signos congestivos recibió terapia depleitiva. Cursó con episodios de FA con RVR con buena respuesta a Amiodarona en bolo + carga, posteriormente con dosis de mantención que suspende al lograr adecuado control de frecuencia con betabloqueo. Se traslapa a terapia oral durante su estadía, logrando INR 1.65 previo al alta con 4 mg/d de acenocumarol, en plan de lograr dosis de anticoagulación en rango en poli TACO.
- 3) Respiratorio: Paciente ingresa cursando insuficiencia respiratoria aguda y compromiso de conciencia con requerimientos de VMI, con lento descenso de parámetros de soporte. Extubación frustra el 04/01 con reintubación en menos de 48 hrs por desaturación y mala mecánica. Dado VMI prolongada y weaning difícil se realizó TQT vía percutánea el 08/01. Durante primera estadía en UTIM evolucionó con nuevo deterioro ventilatorio secundario a patología infecciosa pulmonar, que requirió manejo con VMI nuevamente el 25/01, motivo de reingreso a UPC, avanzó en weaning logrando destete de VMI 2do ciclo el 04/02, con posterior rehabilitación exitosa logrando decanulación el 19/02. Se mantuvo en observación por inicial retención de CO2 tras decanulación, sin requerir medidas adicionales. Presenta difícil retiro de oxigenoterapia, con persistencia de signos de bronquiolitis en imágenes de control, por lo que se lleva a LBA el 12/03 para estudio, considerando inmunosupresión. Posteriormente, sin requerimientos de oxígeno, por lo que se decide alta con UHD.
- 4) Infeccioso: A su ingreso recibió antibioterapia empírica con Ampi/sulbactam, posteriormente se rota a Cloxacilina (FI 02/01) dado CAET (+) SAMS, completa 7 días de terapia dirigida. El 23/01 evoluciona con deterioro ventilatorio, con TAC con progresión de relleno alveolar. Se obtiene segundo CAET (+) P. mirabilis R cotri y Klebsiella. Recibió manejo con tazonom empírico, que escaló a imipenem + vancomicina. Sin otra intercurencia infecciosa posterior.
- 5) Nefrológico: A su ingreso cursó AKI KDIGO III oligoanúrica, sin respuesta a furosemida, recibe TRR en sólo 1 oportunidad por SLED, posteriormente con compensación hemodinámica con lenta resolución logrando independencia de TRR. Se pesquiza hipofosfemia severa posteriormente con requerimiento de carga EV, estudio con PTH levemente aumentada (78) y vitD normal (32.3)
- 6) Gastroenterológico: Cursó con alteración de pruebas hepáticas al ingreso con lenta resolución durante estadía, probablemente en contexto de actividad de HAI y shock séptico. Cursa el 19/01 con dolor abdominal, TAC identifica obstrucción intestinal de asa delgada en contexto de hernia supraumbilical, logrando reducción manual de la misma por equipo de cirugía y posterior manejo médico. En seguimiento con signos de proctitis en TAC, evaluada por coloproctología sugiere realizar colonoscopia, la cual no logra realizar por mala preparación, con posterior evolución favorable y logrando deposiciones diarias con terapia laxante, se dirigió estudio al ambulatorio.
- 7) Reumatológico: Paciente con antecedentes de artritis reumatoide en seguimiento ambulatorio, se suspenden inmunosupresores a su ingreso, con inicio de prednisona a dosis bajas y posterior titulación con suspensión de esta el 24/02. Evaluada por equipo durante estadía con reinicio de hidroxicloroquina, azatioprina, sulfasalazina y abatacept el 26/02.
- 8) Ginecología: Se realiza angioTAC AP (26/02) que informó Engrosamiento endometrial, con plan de estudio del mismo por ecografía transvaginal diferida al ambulatorio.
- 9) Rehabilitación: Mantiene rehabilitación multimodal durante estancia, con interrupción de esta por distintas intercurencias, logrando decanulación el 19/02 y retiro de SNG con alimentación oral exclusiva. Mantiene rehabilitación motora, con avance interferido por dolor de difícil manejo en extremidad inferior izquierda, de carácter neuropático posterior a fracturas en la extremidad, probablemente en contexto de síndrome de dolor loco regional complejo. De lo fonoaudiológico, progresa hasta

Fecha Última Actualización: 17-03-2026 15:30:42

Página 3 de 5

régimen blando sin granos + líquidos claros.

10) Enfermedad Tromboembólica: Se difirió anticoagulación inicialmente en contexto de coagulopatía por sepsis asociada. Reinicia anticoagulación el 14/01 con posterior traslape a TACO con altas dosis de acenocumarol. Seguimiento ambulatorio con PoliTACO.

LABORATORIO RECIENTE

17/03 Hcto 35.7 Hb 10.7 Leucos 4.890 Plq 250.000 ELP 139/4.25/109 pH 7.36 pCO2 42.5 HCO3 23.6 Ca 7.6 Crea 0.54 BUN 11.4 P 1.1 LDH 189 INR 1.65 TTPA 29.3

16/03 ELP 141/3.98/108 Hcto 36.8 Hb 11.3 Leucos 5.150 Plq 257.000 Crea 0.5 BUN 13.8 P 1.1 INR 1.54 TTPA 22.5

15/03 P 0.6

13/03 Láctico 18.3 Albúmina 3.1 Ca 7.8 Crea 0.52 BUN 15.1 P 0.8 Glucosa 72 Mg 2.2 PCR 8.2 ELP 137/4.17/102 pH 7.32 pCO2 49.4 HCO3 25.2 Hcto 34.2 Hb 10.8 Leucos 4.560 Plq 249.000 INR 1.03 TTPA 30.2

MICROBIOLOGÍA DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN:

12/03 PCR TBC Gene Xpert (-) Cultivo (CGP, flora comensal >100.000 UFC) Examen directo al fresco (-) Kinyoun (-) PCR PCP (-) Pendiente: Galactomanano, Cultivo de Nocardia, Cultivo de Hongos, Cultivo de Koch

23/02 Cultivo de Líquido Esteril (-)

23/01 PV y PCR COVID (-), SO NI, UC PMB, CAET (+) P. mirabilis R cotri y Klebsiella.

02/01 CAET (+) SAMS

OTROS EXÁMENES:

23/02 Citoquímico líquido articular: Proteínas totales 21 Glucosa 117 Recuento celular (imposible realizar por viscosidad de líquido)

IMÁGENES

04/03 AngioTAC de Tórax: -Examen sin signos de tromboembolismo pulmonar agudo. -Pequeños focos de relleno alveolar y signos de bronquiolitis celular que predominan en ambos lóbulos superiores, de probable etiología inflamatoria-infecciosa.

26/02 TAC de Abdomen: Arteria renal derecha con múltiples estenosis y dilataciones post estenóticas sugerentes de displasia fibromuscular. Hernia en línea media supraumbilical con contenido adiposo, no complicada. Engrosamiento endometrial que debe ser evaluado de forma dirigida con ecografía trans vaginal. Resto de los hallazgos descritos en el cuerpo del informe.

23/01 TAC AP: Examen sin signos de tromboembolismo pulmonar agudo hasta nivel subsegmentario proximal. Aumento en extensión de las múltiples opacidades de relleno alveolar pulmonares bilaterales, de probable etiología inflamatoria - infecciosa. Signos tomográficos de un fecaloma. Hernia de línea media supraumbilical, de contenido adiposo, sin signos de complicación actual. Resolución de la dilatación en rango patológico de asas de intestino delgado. Resto del estudio sin cambios significativos.

19/01 TAC Tórax: -Obstrucción intestinal de asas de intestino delgado con cambio de calibre en relación a hernia supraumbilical, sin un claro realce del asa contenido en saco herniario hallazgo sugerente de isquemia y/o necrosis. -Signos sugerentes de proctitis. -Progresión en signos de bronquiolitis en pulmón derecho y aparición de nódulos pulmonares bilaterales también posiblemente en contexto de etiología inflamatoria infecciosa. Derrame pleural laminar bilateral -Acentuada cardiomegalia. -Distensión de la cavidad endometrial. Realizar estudio ginecológico dirigido

30/12 AngioTAC TAP: Examen sin signos de tromboembolismo pulmonar agudo. Leve derrame pleural laminar bilateral. Neumopatía multifocal de posible origen inflamatorio infeccioso, con signos de extenso compromiso de vía aérea pequeña. Correlacionar con elementos clínicos y controlar. Catéter venoso central femoral derecho con extremo distal en vena iliaca común derecha con escaso trombosis no oclusiva pericatóter según lo descrito. Resto en el cuerpo del informe

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

1. Espasmo laríngeo y bronquial inducido, resuelto

2. Insuficiencia respiratoria parcial resuelta

- Obs infeccioso vs reumatológico: nódulo/relleno alveolar

- LBA 12/03

3. Hipofosfatemia en estudio

- PTH elevada, Vit D normal, eucalcemia

4. Crítica crónica en rehabilitación

- 1° VMI 28/12 - 08/01 à TQTp 08/01

- 2° VMI 23/01 - 05/02

- Decanulación 19/02

Fecha Epicrisis : 17/03/2026 15:30

Página 3 de 5

Fecha de Impresión : Miércoles, 25 de Marzo de 2026 23:48

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

5. LCFA

- EPOC dg 2023

- Obs bronquiolitis 2° a AR

6. FA permanente en TACO

7. Anemia moderada NH

8. Alodinia EID

Resueltos:

FA con RVR yugulada

NAAS P. mirabilis + K. pneumoniae, tratada

Obstrucción intestinal de asa delgada por hernia supraumbilical, resuelta

- Reducción manual por cx 20/01

Shock séptico de foco pulmonar, recuperado

- NAC por SAMS tratada

- AKI KDIGO III 2° shock, recuperada. TRR x1 vez (SLED)

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria Aguda -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable. Sin requerimientos de oxígeno suplementario. Signos vitales dentro de rango normal. Sin sintomatología aguda actual. En condiciones de egreso hospitalario.

Plan Post Alta

INDICACIONES

GENERALES

Reposo relativo. Progresar en rehabilitación con kinesioterapia

Régimen blando sin granos, líquidos claros. Consumir carnes rojas.

Hospitalización Domiciliaria: Progresar en rehabilitación kinésica.

MEDICAMENTOS

Agregar medicamentos:

Bisoprolol 5 mg, medio comprimido (2.5 mg) cada 24 horas vía oral

Budesonida 2 puff cada 12 horas con aerocámara

Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 6 horas vía oral

Metamizol 300 mg, 1 comprimido cada 8 horas vía oral

Duloxetine 30 mg, 2 comprimidos cada 24 horas vía oral

Pregabalina 75 mg, 1 comprimido cada 24 horas vía oral

Acenocumarol 4 mg, 1 comprimido cada 24 horas vía oral (4 mg de Lunes a Domingo)

Berodual (Bromuro de Ipratropio/Fenoterol) 2 puff cada 6 horas con aerocámara

Salbutamol 2 puff con aerocámara SOS en caso de obstrucción

Quetiapina 25 mg, medio comprimido (12.5 mg) en las noches vía oral

PEG 3350, 15 g en 200 cc de agua SOS en caso de constipación, cada 24 horas vía oral

Modificar Dosis:

Sulfasalazina 500 mg, 2 comprimidos cada 24 horas vía oral

Atorvastatina 20 mg, 2 comprimidos cada 24 horas vía oral

Mantener medicamentos de uso habitual:

Abatacept 125 mg cada semana, vía subcutánea

Azatioprina 50 mg, 2 comprimidos cada 24 horas vía oral

Hidroxycloquin 200 mg, 1 comprimido cada 24 horas vía oral

EiCalD 500 mg/800 UI, 1 comprimido cada 24 horas vía oral

Omeprazol 20 mg, 1 cápsula cada 24 horas vía oral

Spolto (Tiotropio/Olodaterol) 1 inhalación cada 24 horas

Medicamentos a suspender:

Fecha Epicrisis : 17/03/2026 15:30

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 17-03-2026 15:30:42

Página 5 de 5

Aspirina, evaluar reinicio se suspende la anticoagulación
Furosemida
Bromuro de Ipratropio

CONTROLES

Control de exámenes de sangre el día 23/03/2026 a las 07:30 en Pasillo 2 del CDT. Se entrega orden de exámenes junto con epicrisis. Acudir en ayunas. Mencionar que viene desde Medicina Interna para control post alta.

Control con Dra. Daza en Policlínico de Alta (CDT pasillo 6), Medicina Interna, el día 24/03/2026 a las 14:30, en el CDT.

Controles con poli TACO para ajuste de anticoagulación, se realiza interconsulta.

Control con cirugía de hernias, se realiza interconsulta.

Control con ginecología, se realiza interconsulta.

Realizar colonoscopia de forma ambulatoria, se realiza interconsulta

Mantener seguimiento con broncopulmonar, se coordinará control

Mantener seguimiento con reumatología, se coordinará control

Mantener el resto de sus controles crónicos habituales.

Acudir al servicio de urgencias en caso de fiebre $>38^{\circ}\text{C}$, dificultad respiratoria, dolor torácico, intolerancia vía oral, diarrea de alto volumen o acompañadas de mucosidades y/o sangre, compromiso de conciencia o cuando estime conveniente.

Dr. San Martín

Indicaciones

Tipo de Reposo : En Rehabilitación

Régimen Alimentario : Regimen Blando Sin Granos + Líquidos Claros

Medicamentos :

Controles

Francisca Quintanilla Perez

INTERNO

Becado/Residente

Nicolás Andrés San Martín Reyes

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 17/03/2026 15:30

Página 5 de 5

Fecha de Impresión : Miércoles, 25 de Marzo de 2026 23:48

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar